

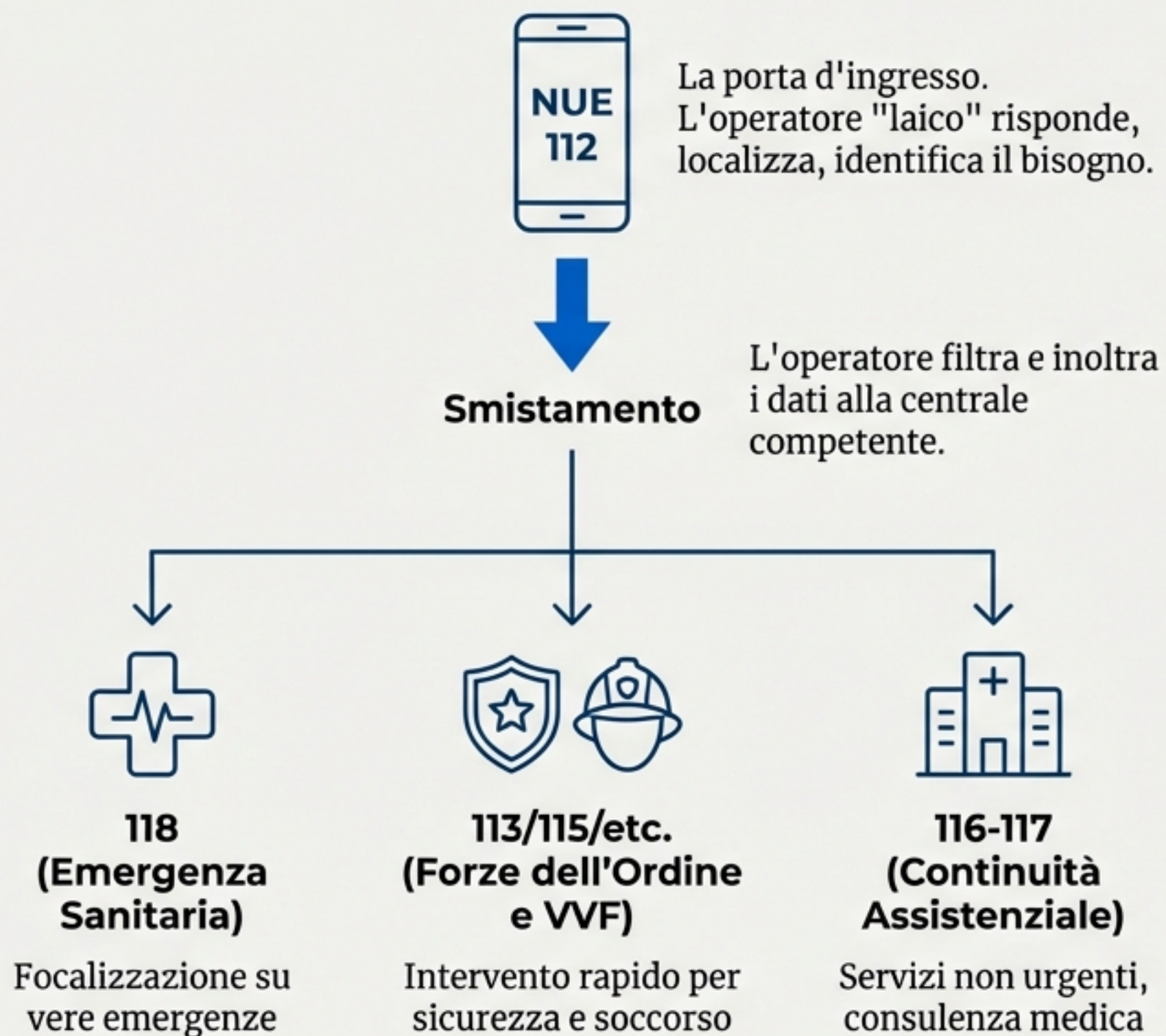
Dal Ruolo alla Responsabilità: Il Percorso del Professionista del Soccorso

Guida Essenziale per l'Addetto al Trasporto Sanitario (TS) in Lombardia



Benvenute e benvenuti. Questo percorso è stato creato per voi, futuri colleghi, per fornirvi le fondamenta tecniche, operative e umane del vostro nuovo ruolo. Non si tratta solo di imparare procedure, ma di capire chi diventerete.

Il Vostro Mondo: Il Sistema di Emergenza Lombardo



Ogni intervento inizia con una chiamata al **Numero Unico Europeo 112**.

Operatori specializzati non sanitari (laici) gestiscono il primo contatto, agendo come un filtro intelligente.

Questo processo "toglie lavoro" improprio alla centrale sanitaria del 118, permettendole di concentrarsi sulle vere emergenze.

La Lombardia è stata pioniera in questo modello, oggi nazionale.



L'app "Where Are U" è uno strumento fondamentale per la localizzazione GPS precisa del chiamante.

Chi Siete Voi?

Distinguere i Ruoli nel Trasporto Sanitario



TSS (Trasporto Sanitario Semplice)

Accompagnamento di persone per motivi sanitari che non necessitano di assistenza clinica durante il viaggio.



TS (Trasporto Sanitario)

Il vostro ruolo. Trasporto con ambulanze allestite per pazienti che richiedono monitoraggio e personale con formazione specifica (corso 42 ore, BLSD incluso).



SSE (Soccorso Sanitario Extraospedaliero)

Intervento in emergenza-urgenza attivato dal 118. Richiede la qualifica superiore di "Soccorritore Esecutore".

Il ruolo di Addetto TS è la base fondamentale e il requisito per poter accedere al percorso di Soccorritore Esecutore. È un percorso a gradini, basato su competenze crescenti.

La Formazione: Le Fondamenta della Vostra Professionalità

L'improvvisazione è pari a zero. La DGR 5165 e il RGE 34 definiscono un percorso formativo obbligatorio e certificato da un CEFRA accreditato AREU.



Le Competenze Chiave: Salvare una Vita con il BLSD



Riconoscimento e
attivazione del sistema
di risposta all'emergenza

RCP immediata di
alta qualità

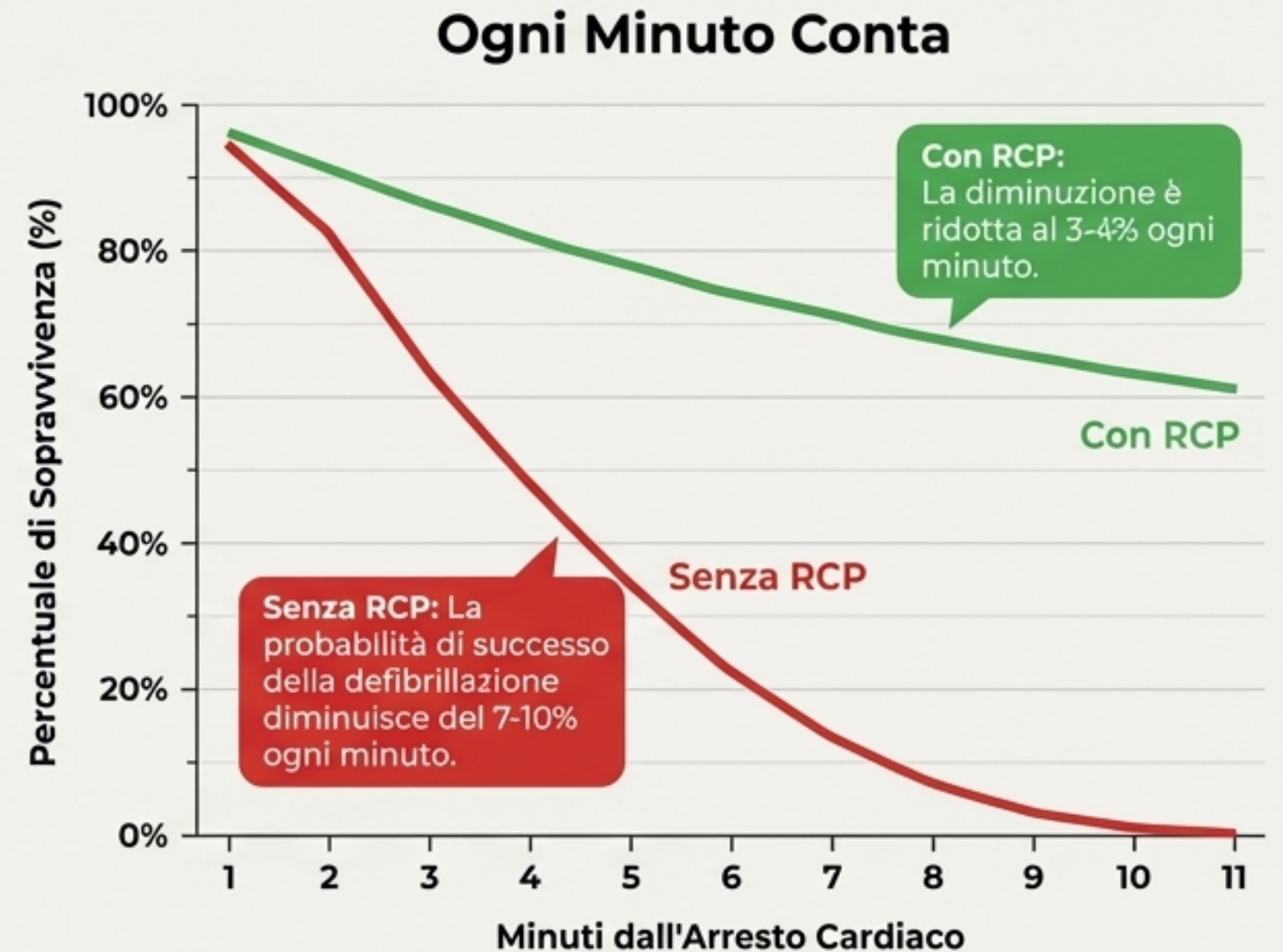
Defibrillazione
rapida

Sistema di Emergenza
Territoriale di base
e avanzato

Supporto vitale e
assistenza post
arresto avanzati

«Le manovre che vedremo insieme non sono solo la base del nostro lavoro, ma sono quelle che possono davvero, e dico davvero, fare la differenza tra la vita e la morte.»

Morte Cardiaca Improvvisa: Una Corsa Contro il Tempo



L'Arresto Cardiaco è un problema elettrico che ferma il cuore. La RCP immediata non riavvia il cuore, ma mantiene il cervello e gli organi vitali ossigenati, guadagnando tempo prezioso per l'arrivo del DAE.

La Catena della Sopravvivenza: La Vostra Mappa per l'Azione



**1. Riconoscimento e Attivazione
(Chiamata NUE 112):**
La chiamata che avvia tutto.

2. RCP Immediata di Alta Qualità:
Le vostre mani sul torace.

3. Defibrillazione Rapida:
L'uso del DAE.

4. Sistema di Emergenza Avanzato:
L'arrivo dell'ambulanza medicalizzata.

5. Supporto Vitale Avanzato Post-Arresto:
Le cure in ospedale.

Voi siete gli **anelli cruciali che collegano la vittima alla **sopravvivenza**.
Il vostro ruolo si concentra in modo massiccio sui primi tre anelli.**

RCP di Alta Qualità: Comprare Tempo per il Cuore

Non basta fare il massaggio cardiaco, bisogna farlo bene. La qualità di queste manovre è direttamente legata alla speranza di vita del nostro paziente.

Parametri Chiave



RAPPORTO: 30/2

30 Compressions :
2 Ventilazioni



FREQUENZA: 100-120

compressioni al minuto
(il ritmo di 'Stayin' Alive')



PROFONDITÀ:

Almeno 5 cm
(ma non più di 6 cm)



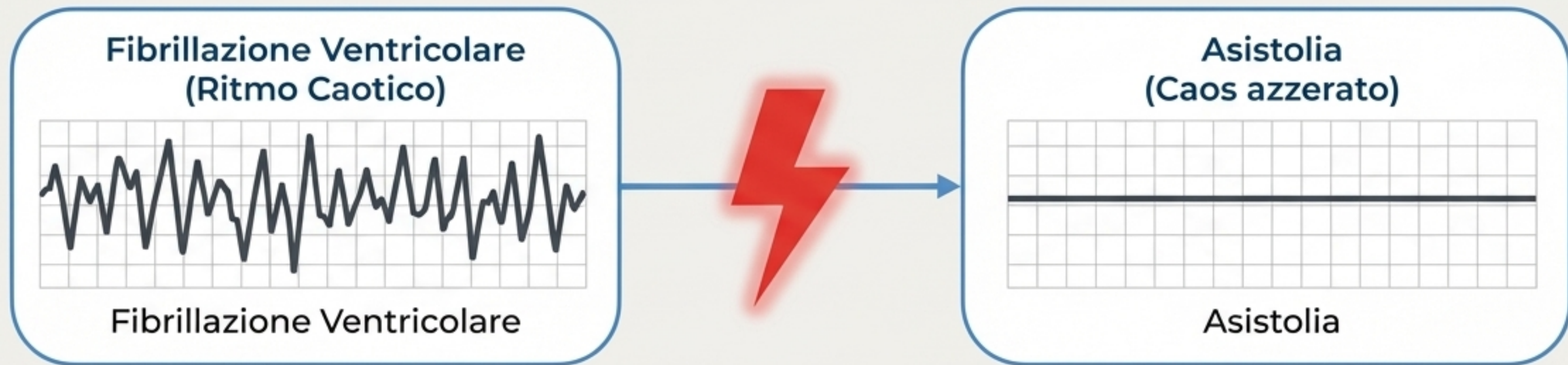
RIESPANSIONE

Consentire la completa
riespansione del torace
dopo ogni compressione.

Le interruzioni devono essere ridotte al minimo indispensabile.
Ogni secondo senza massaggio è un passo indietro enorme.

Come Funziona Davvero il DAE? Resetare il Caos Elettrico

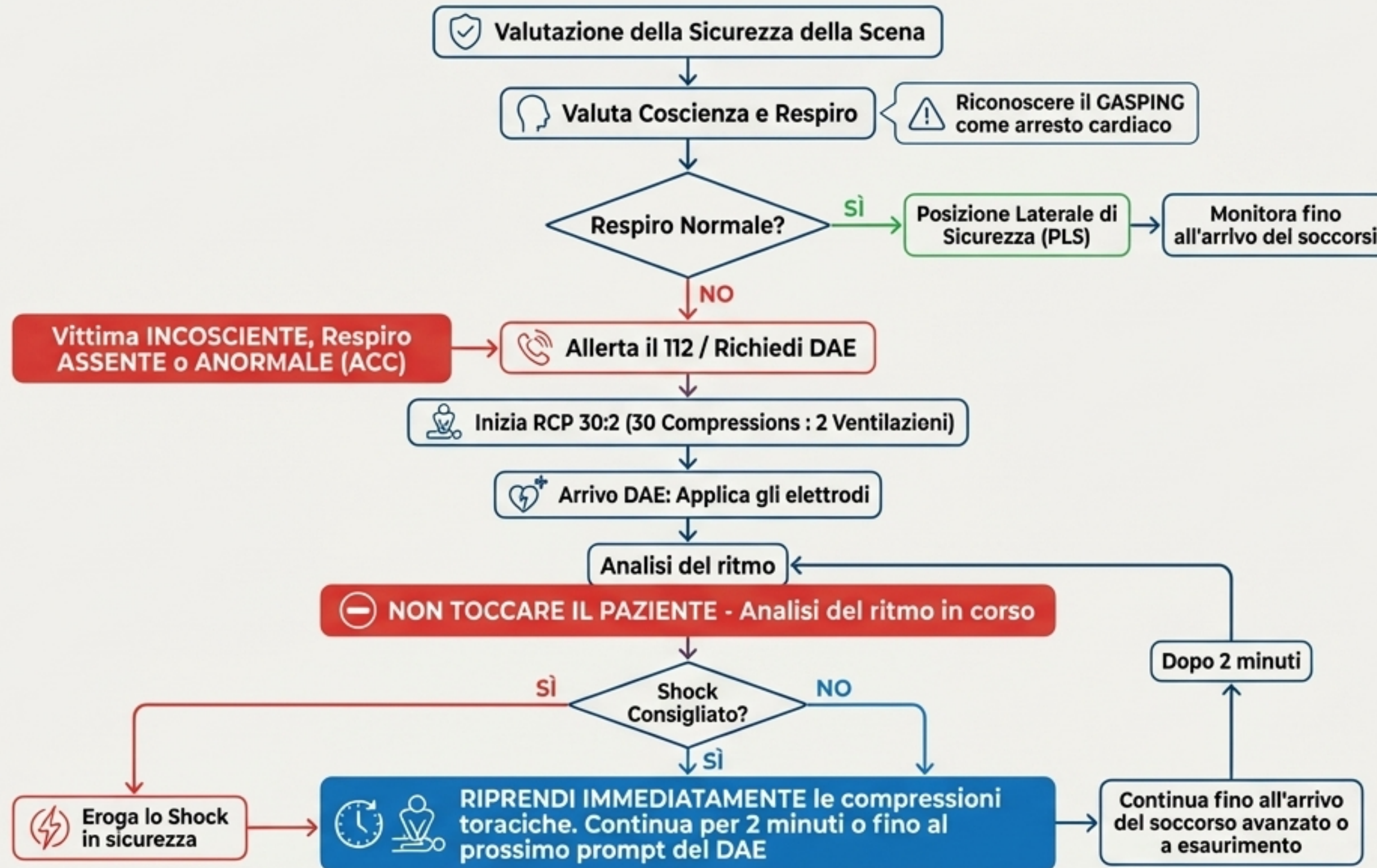
Sfatiamo subito un mito. Il DAE **NON** fa ripartire un cuore fermo (asistolia). La sua funzione è un'altra: fermare un'attività elettrica caotica e inefficace (Fibrillazione Ventricolare) per dare al cuore la possibilità di riprendere un ritmo normale.



DAE -> BLOCCA il cuore.

- L'operatore è responsabile della sicurezza della procedura (es. nessuno tocca il paziente), ma **non** della decisione di erogare lo shock. Quella è una valutazione della macchina.

L'Algoritmo Completo BLSD per l'Adulto



Nota a piè di pagina: Il DAE ripeterà l'analisi ogni 2 minuti. Questo è il momento ideale per cambiare l'operatore alle compressioni per garantire la massima efficacia e ridurre la fatica.

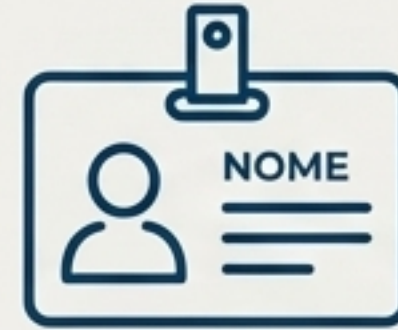
L'Azione: Il Paziente al Centro



«La vera abilità sta nell'unire la tecnica all'empatia. Significa guardare negli occhi la persona che abbiamo di fronte, capire la sua paura e usare il nostro pensiero critico per decidere cosa è davvero meglio per lei in quel momento.»

Costruire la Fiducia: I 4 Pilastri della Comunicazione

Questi quattro passaggi trasformano un'azione puramente tecnica in un vero e proprio atto di cura. Devono diventare un riflesso condizionato.



1. PRESENTARSI

«Buongiorno, sono [Nome], della Croce Verde. Siamo qui per aiutarla.» - Stabilisce professionalità e ruolo.



1. PRESENTARSI

«Buongiorno, sono [Nome], della Croce Verde. Siamo qui per aiutarla.» - Stabilisce professionalità e ruolo.



2. ASCOLTARE

«Ascoltare attivamente, non solo stare zitti. Chiamare la persona per nome le restituisce dignità.»



3. SPIEGARE

«Ora le misuro la pressione, sentirà il braccio stringere un po'.» Spiegare ogni gesto riduce la paura dell'ignoto.



4. RASSICURARE (con onestà)

NO: «Andrà tutto bene».
SÌ: «Faremo tutto il possibile per aiutarla. Adesso ci pensiamo noi a lei.»

Non Esiste il Paziente Standard: Adattare l'Approccio



Paziente Psichiatrico / Alterato

Priorità: Sicurezza dell'equipaggio.

Azione: Restare calmi, non giudicare. Se la scena non è sicura, attendere le **Forze dell'Ordine**.



Paziente in Fase Terminale

Priorità: Rispetto della volontà.

Azione: Non essere invasivi. Contattare la **centrale operativa** e seguire le indicazioni del **medico**.



Paziente Ustionato

Priorità: Protezione termica e sterilità.

Azione: Coprire per evitare l'**ipotermia**, mantenere l'igiene per prevenire infezioni.



Paziente Dializzato

Priorità: Protezione della fistola.

Azione: **MAI** misurare la pressione sul braccio con la **fistola artero-venosa**.



Bambino

Priorità: Conquistare la fiducia.

Azione: Coinvolgere i **genitori**. Mettersi al loro livello fisico, usare un **tono di voce calmo**.

Mobilizzazione Atraumatica: Proteggere la Colonna Vertebrale

Se sospettate anche solo minimamente una lesione alla colonna, ogni movimento è finalizzato a proteggerla. L'obiettivo è non creare nessun nuovo trauma.



1. Immobilizzazione Manuale

Soccorritore 1 (alla testa): Mantiene l'immobilizzazione manuale del capo in posizione neutra.



2. Valutazione e Misurazione

Soccorritore 2: Parla col paziente, ispeziona il collo, misura la taglia corretta del collare.



3. Applicazione del Collare

Soccorritore 2: Posiziona prima la parte anteriore, poi quella posteriore, chiudendo i velcri simmetricamente.



CRUCIALE: Anche con il collare posizionato, **l'immobilizzazione manuale della testa non si lascia MAI** fino a quando il paziente non è completamente fissato alla tavola spinale con i fermacapo.

La Responsabilità del Professionista

Indossare questa divisa significa assumersi un carico di responsabilità legali, etiche e personali. Non è solo ciò che fate, ma come e perché lo fate a definirvi come professionisti del soccorso.

Tra Codice e Coscienza: Doveri Legali ed Etici



Responsabilità Legale (in particolare per l'autista)

Riferimento: Art. 2054 Codice Civile.

L'autista è **responsabile** a meno che non dimostri di "**aver fatto tutto il possibile per evitarlo**". Questo richiede un principio di cautela che va oltre il semplice rispetto delle regole.

- Menzionare Art. 140 (non creare pericolo) e 177 (mezzi di soccorso) del Codice della Strada.



Responsabilità Etica (per tutto l'equipaggio)

Riferimento: GDPR e D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy).

Obbligo di **riservatezza assoluto** sui dati sensibili. La violazione del segreto professionale e d'ufficio è un **reato penale** (**Art. 326 Codice Penale**).

La Vostra Prima Responsabilità Inizia Prima della Chiamata

La vostra responsabilità più grande non inizia davanti al paziente, ma nel momento in cui mettete piede in sede. È vostro dovere controllare l'ambulanza e ogni presidio, in particolare il defibrillatore: carica, placche non scadute, kit completo.

> “Arrivare su un intervento e scoprire che il DAE ha la batteria scarica non è sfortuna, è un nostro fallimento. E non ce lo possiamo permettere.”



Oltre la Tecnica: Prendersi Cura di Chi Cura

Affrontiamo situazioni difficili, a volte traumatiche. È normale che questo lasci un segno. La cosa peggiore è fare finta di niente.

La risorsa più importante è il vostro equipaggio. A fine turno, parlatene.

Praticate il “debriefing”: pochi minuti per condividere cosa ha funzionato, cosa vi ha scosso, come vi sentite. È un atto di professionalità e di cura verso voi stessi e i vostri colleghi.

La vostra professionalità si misura non solo nelle emergenze che gestite, ma anche nella capacità di supportarvi a vicenda. È questo che fa di voi non solo dei tecnici, ma una squadra e una comunità.

